

# Anesthésie pour amygdalectomie chez l'enfant

Méthodologie, légende &amp; Q1 — Évaluation préopératoire



**Champ** : prise en charge anesthésique péri-opératoire de l'enfant opéré pour amygdalectomie (avec ou sans adénoïdectomie). En France, l'anesthésie ORL représente 12 % des actes (3e rang après orthopédie et chirurgie digestive) ; sur ~670 000 anesthésies ORL annuelles, 17 % le sont pour amygdalectomie. L'anesthésie ORL représente 25 % des actes chez les moins de 1 an, 64 % chez les 1-4 ans, 28 % chez les 5-14 ans. Malgré les progrès, il persiste une morbi-mortalité non négligeable.

**Méthodologie** : ce document combine **deux systèmes de cotation** — des propositions fondées sur la littérature (Grade A/B/C selon le niveau de preuve) et des propositions validées par cotation RAND/UCLA modifiée des experts en l'absence de preuve suffisante (« Accord fort » ou « Accord faible »). Chaque proposition du texte source porte l'un ou l'autre de ces deux tags, jamais les deux à la fois — reproduit tel quel, sans fusionner les deux échelles.

## Légende des cotations

A

B

C

**Niveaux de preuve (Grade A/B/C)** — fondés sur la littérature (A : ≥2 études de niveau I ; B : 1 étude de niveau I ; C : étude(s) de niveau II). Aucune proposition D ou E dans ce texte.

Fort

Faible

**Accord RAND/UCLA modifié (1-9)** — cotation individuelle des experts en l'absence de preuve suffisante : « Accord fort » (intervalle borné dans une seule zone) ou « Accord faible » (intervalle empiétant sur une borne).

## Question 1 — Évaluation préopératoire et préparation à la chirurgie

### 1.1 — Objectifs et modalités de la consultation d'anesthésie, information sur le risque

| Proposition                                                                                                                                                                        | Cotation |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| La consultation d'anesthésie en prévision d'une amygdalectomie a deux buts essentiels : l'évaluation des risques inhérents à l'acte et l'information du patient et de ses parents. | Fort     |
| L'évaluation des risques repose sur l'interrogatoire des parents et si possible de l'enfant, ainsi que sur l'examen clinique de l'enfant.                                          | Fort     |
| Les risques respiratoires et hémorragiques doivent faire l'objet d'une attention et d'une information particulières.                                                               | Fort     |
| Le risque respiratoire est majoré en cas de syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS) grave.                                                                                  | Fort     |
| L'information s'adresse à la fois à l'enfant et aux parents, et doit être adaptée au degré de compréhension de chacun.                                                             | Fort     |

### 1.2 — Bilan préopératoire

| Proposition                                                                                                                                                                                                                                                  | Cotation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| L'évaluation préopératoire du risque hémorragique repose sur un interrogatoire précis à la recherche d'antécédents personnels et/ou familiaux suggérant une anomalie de l'hémostase, et sur un examen clinique recherchant une symptomatologie hémorragique. | Fort     |
| En cas d'antécédents personnels ou familiaux d'hémorragie connus ou suspectés, ou lorsque l'évaluation préopératoire ne peut être considérée comme fiable (notamment chez l'enfant de moins de 3 ans), une étude de l'hémostase doit être réalisée.          | Fort     |
| Les résultats de cette étude initiale, s'ils restent anormaux après contrôle, doivent être discutés avec un spécialiste de l'hémostase afin de déterminer l'opportunité d'une étude plus approfondie.                                                        | Fort     |
| Si des examens d'hémostase sont prescrits, le temps de céphaline avec activateur et la numération plaquettaire sont les tests les plus utiles.                                                                                                               | Fort     |
| Chez l'enfant de plus de 3 ans, lorsque l'évaluation clinique préopératoire ne dépiste pas de risque hémorragique anormal, l'étude systématique de l'hémostase ne s'impose pas.                                                                              | Fort     |

# Anesthésie pour amygdalectomie chez l'enfant

Méthodologie, légende &amp; Q1 — Évaluation préopératoire



## 1.3 — Gestion d'une infection des voies aériennes supérieures (IVAS) avant amygdalectomie

| Proposition                                                                                                                                          | Cotation |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| L'amygdalectomie majore le risque de complications respiratoires du fait de la localisation du site chirurgical sur les voies aériennes supérieures. | A        |
| Ces complications respiratoires contribuent à générer une morbidité dénuée de réelle gravité si l'anesthésiste est expérimenté dans ce contexte.     | B        |
| L'IVAS entraîne une fréquence accrue de complications respiratoires telles que désaturation et pause respiratoire.                                   | A        |
| L'IVAS entraîne une augmentation de la fréquence des bronchospasmes lorsque l'enfant est intubé.                                                     | A        |

## 1.4 — Critères de report d'intervention en cas d'IVAS

L'intervention est différée si l'enfant présente *[Accord fort]* :

- des signes spastiques bronchiques ;
- une laryngite ;
- une température supérieure à 38 °C.

| Proposition                                                                                  | Cotation |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| En cas de report d'intervention, le délai de re-programmation est d'au moins trois semaines. | Fort     |

## 1.5 — Conséquences du syndrome d'apnée du sommeil (SAOS) sur la prise en charge anesthésique

| Proposition                                                                                                                                                                                                                          | Cotation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Le SAOS représente environ deux tiers des indications d'amygdalectomie.                                                                                                                                                              | Fort     |
| Les enfants concernés ont le plus souvent moins de 5 ans.                                                                                                                                                                            | Fort     |
| En l'absence de critères de gravité, le SAOS ne modifie habituellement pas la prise en charge anesthésique.                                                                                                                          | Fort     |
| Les formes graves de SAOS sont plus fréquentes chez le jeune enfant et en cas de dysmorphie faciale ou de pathologies associées.                                                                                                     | Fort     |
| Les formes graves de SAOS nécessitent une évaluation préopératoire du retentissement cardio-pulmonaire, et justifient une surveillance postopératoire d'au moins 24 heures dans une structure de type SSPI ou surveillance continue. | Fort     |

# Anesthésie pour amygdalectomie chez l'enfant

## Q2 — Prise en charge anesthésique



### Question 2 — Prise en charge anesthésique des enfants programmés

#### 2.1 — Prise en charge anesthésique des patients

| Proposition                                                                                                                                                                                                      | Cotation |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Les règles de jeûne habituelles, adaptées à l'âge de l'enfant, doivent être appliquées.                                                                                                                          | C        |
| En dehors des syndromes obstructifs graves, une prémédication anxiolytique est utile.                                                                                                                            | C        |
| Les structures de prise en charge et le matériel utilisé doivent être conformes aux recommandations de la Sfar et de l'Adarpef.                                                                                  | Fort     |
| La surveillance peropératoire repose sur un monitoring conforme aux recommandations de la Sfar.                                                                                                                  | Fort     |
| L'anesthésie générale lors de l'amygdalectomie a pour but d'assurer une composante hypnotique suffisante pour éviter la mémorisation peropératoire, et une composante analgésique efficace.                      | Fort     |
| L'induction par inhalation est la modalité la plus fréquente.                                                                                                                                                    | Fort     |
| L'induction intraveineuse est parfois préférée chez les grands enfants ou en cas de syndrome obstructif sévère.                                                                                                  | Fort     |
| L'entretien de l'anesthésie est souvent assuré par un agent halogéné associé à un morphinique.                                                                                                                   | Fort     |
| Les apports hydroélectrolytiques peropératoires reposent sur l'utilisation d'un soluté isotonique en sel, pouvant contenir une faible concentration de glucose et perfusé à un débit adapté à l'âge de l'enfant. | Fort     |
| Débit de perfusion — règle des 4-2-1 : 4 mL/kg/h pour les 10 premiers kg, + 2 mL/kg/h pour les 10 kg suivants, + 1 mL/kg/h pour les 10 kg suivants (soit 65 mL/h pour un enfant de 25 kg par exemple).           | Fort     |
| Il est recommandé d'utiliser un dispositif médical de contrôle du débit de perfusion.                                                                                                                            | Fort     |
| L'administration peropératoire de dexaméthasone est recommandée car elle réduit l'incidence des NVPO et le délai avant la reprise alimentaire.                                                                   | B        |
| L'administration d'une antibioprophylaxie peropératoire n'a pas démontré son intérêt, et ne s'impose donc pas systématiquement.                                                                                  | Fort     |

#### 2.2 — Modalités de contrôle des voies aériennes

| Proposition                                                                                                                                       | Cotation |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| L'amygdalectomie chez l'enfant requiert une anesthésie générale balancée impliquant une protection des voies aériennes.                           | Fort     |
| Le contrôle optimal des voies aériennes est assuré par une sonde d'intubation trachéale à ballonnet.                                              | Fort     |
| L'extubation est réalisée, en présence d'un médecin anesthésiste, au réveil complet de l'enfant, déterminé par l'ouverture des yeux à la demande. | Fort     |



### Question 3 — Organisation des soins postopératoires

#### 3.1 — Modalités de surveillance postopératoire

| Proposition                                                                                                                                                                                                   | Cotation |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| La surveillance en SSPI doit être systématique.                                                                                                                                                               | Fort     |
| En plus de la surveillance habituelle, le dépistage et le traitement éventuel des complications respiratoires et hémorragiques est indispensable.                                                             | Fort     |
| La surveillance en SSPI peut être prolongée chez les jeunes enfants opérés dans un contexte de SAOS grave.                                                                                                    | Fort     |
| La sortie de SSPI est autorisée après vérification des critères habituels (respiration, état hémodynamique, conscience, douleur, NVPO) et vérification de l'absence de saignement pharyngé par le chirurgien. | Fort     |

#### 3.2 — Perfusion postopératoire, reprise des boissons et de l'alimentation

| Proposition                                                                                                                                                                      | Cotation |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Les apports hydroélectrolytiques postopératoires reposent sur un soluté isotonique en sel, pouvant contenir une faible concentration de glucose.                                 | Fort     |
| La perfusion est poursuivie jusqu'à la reprise efficace des boissons.                                                                                                            | Fort     |
| En raison du risque hémorragique, la reprise de l'alimentation s'effectue 6 heures après la fin de l'intervention ; la reprise des liquides clairs est possible dès la 2e heure. | Fort     |
| Un régime alimentaire spécifique n'a pas fait la preuve de sa supériorité par rapport à une alimentation libre après amygdalectomie.                                             | C        |

#### 3.3 — Modalités de l'analgésie postopératoire

La douleur post-amygdalectomie est considérée comme une douleur forte à composante inflammatoire, durant en moyenne 8 jours (maximum les 3 premiers jours). *[Accord fort]*

| Proposition                                                                                                                                                                                                                                     | Cotation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| L'évaluation et le traitement de la douleur doivent être systématiques, y compris à domicile.                                                                                                                                                   | C        |
| L'utilisation du paracétamol doit être large, quasi-systématique ; les voies IV et orale sont les plus fiables.                                                                                                                                 | B        |
| Seule la morphine est efficace en monothérapie, administrée par voie IV en SSPI ; elle est considérée comme l'antalgique de référence. Les autres analgésiques doivent être utilisés en association et en tenant compte de leur délai d'action. | C        |
| La posologie de la morphine doit être réduite en cas de SAOS grave.                                                                                                                                                                             | Fort     |
| Les antalgiques du palier II en association avec le paracétamol peuvent prendre le relais de la morphine IV. Leur administration par voie orale doit être débutée dès que possible.                                                             | C        |
| Les AINS non sélectifs ne sont pas recommandés car ils peuvent s'associer à une augmentation de la fréquence des reprises chirurgicales pour saignement.                                                                                        | Faible   |

# Anesthésie pour amygdalectomie chez l'enfant

## Q4 — Complications postopératoires



### Question 4 — Complications postopératoires et prise en charge

#### 4.1 — Principales complications postopératoires

| Proposition                                                                                                                                                                                                             | Cotation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Les principales complications primaires (avant la 24e heure) sont : les complications respiratoires, l'hémorragie et les nausées et vomissements.                                                                       | B        |
| Les principaux facteurs de risque de complications respiratoires sont : la gravité du SAOS et l'importance de la désaturation artérielle préopératoire.                                                                 | C        |
| Chez les patients atteints de SAOS, 70 % des complications respiratoires majeures surviennent dans la première heure postopératoire, alors que les complications mineures surviennent habituellement avant la 6e heure. | C        |
| L'hémorragie postopératoire survient chez 0,5 à 3 % des patients.                                                                                                                                                       | B        |
| 80 % des hémorragies primaires surviennent avant la 6e heure.                                                                                                                                                           | B        |
| Environ 25 % des hémorragies postopératoires vont nécessiter une reprise chirurgicale.                                                                                                                                  | C        |
| Les patients nécessitant une reprise chirurgicale pour hémostase doivent être considérés comme ayant l'estomac plein et justifient une induction en séquence rapide.                                                    | Fort     |

#### 4.2 — Nausées et vomissements postopératoires (NVPO)

| Proposition                                                                                                                    | Cotation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Après amygdalectomie, on observe des nausées et vomissements chez 40 à 70 % des patients.                                      | C        |
| L'utilisation peropératoire de protoxyde d'azote ne modifie pas l'incidence des NVPO.                                          | C        |
| Les NVPO sont moins fréquentes après injection peropératoire de propofol.                                                      | C        |
| L'administration prophylactique IV de sétron réduit significativement l'incidence des NVPO après amygdalectomie chez l'enfant. | C        |
| La dexaméthasone réduit significativement l'incidence des NVPO, et potentialise l'efficacité des sétrons.                      | C        |
| Des protocoles de prise en charge des NVPO doivent être prévus et accessibles en SSPI.                                         | Fort     |



### Question 5 — Conditions requises pour l'amygdalectomie en ambulatoire

La réalisation de l'amygdalectomie en ambulatoire est possible si *[Accord fort]* :

- l'enfant est âgé de plus de 3 ans ;
- il n'existe pas de comorbidité majorant notamment le risque respiratoire ;
- il n'existe pas d'anomalie de l'hémostase ;
- il n'existe pas de syndrome d'apnée du sommeil grave ;
- les critères habituels de proximité et d'entourage familial sont satisfaits ;
- et sous réserve d'un consensus entre le chirurgien, l'anesthésiste et les parents.

| Proposition                                                                                                                                                                  | Cotation |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| L'intervention doit être réalisée le plus tôt possible dans la matinée afin de permettre la sortie après une surveillance postopératoire de 6 heures.                        | Fort     |
| La gestion anesthésique doit privilégier la prévention des NVPO, et l'anticipation peropératoire de l'analgésie postopératoire.                                              | Fort     |
| Le relais antalgique oral devrait être débuté avant la sortie du patient.                                                                                                    | Fort     |
| Il est recommandé de remettre aux parents un document avec les coordonnées de la personne à contacter en cas de difficultés, ainsi que l'ordonnance d'antalgiques de sortie. | Fort     |

La sortie de l'enfant est autorisée après la 6e heure postopératoire, si les critères suivants sont réunis *[Accord fort]* :

- absence de saignement au niveau des loges amygdaliennes, confirmée par le chirurgien ;
- absence de douleur ;
- absence de NVPO ;
- accord signé du chirurgien et de l'anesthésiste.

| Proposition                                                                                                                   | Cotation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Un suivi téléphonique du patient à domicile à la 24e heure est souhaitable, car il améliore la qualité de la prise en charge. | Fort     |

### Sources et traçabilité

**Document source** : « Anesthésie pour amygdalectomie chez l'enfant » — Conférence d'experts, texte court. Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR), Association des anesthésistes réanimateurs pédiatriques d'expression française (Adarpef), Club de l'anesthésie réanimation en ORL (Carorl). Secrétaire : Pr I. Constant ; Président : Pr G. Orliaguet.

**Version** : 2005 (dépôt légal novembre 2006).

**Méthodologie** : Conférence d'experts — deux systèmes de cotation combinés : niveaux de preuve (Grade A/B/C selon la littérature) et cotation RAND/UCLA modifiée (« Accord fort/faible ») pour les propositions sans preuve suffisante — voir disclosure méthodologique en page 1.

**URL source** : [https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2a\\_SFAR\\_TEXTE-COURT\\_Anesthesie-pour-amygdalectomie-chez-lenfant.pdf](https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2a_SFAR_TEXTE-COURT_Anesthesie-pour-amygdalectomie-chez-lenfant.pdf)

**Couverture** : cette fiche reprend l'intégralité des 5 questions / 12 sous-questions du texte court (évaluation préopératoire, prise en charge anesthésique, soins postopératoires, complications, ambulatoire).

**Avertissement — document de 2005** : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des propositions du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques) et n'est ni éditée ni validée par la SFAR, l'Adarpef ou le Carorl. Les pratiques ayant pu évoluer depuis 2005, se référer en cas de doute au texte intégral, aux recommandations plus récentes le cas échéant, et/ou à un avis spécialisé.